

Эпидемиология

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАКА ПИЩЕВОДА ПО

Г. АЛМАТЫ

Калиева Ж.Ж., Игисинов С.И.,

Бегимбаева Р.С., Джарылкасымова Ж.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы

Актуальность. Рак пищевода (РП) занимает 6 место в структуре смертности от злокачественных опухолей в мире. География и в некоторой степени принадлежность больного к той или иной этнической группе влияет на показатели заболеваемости РП. А в общем числе опухолей, встречающихся у человека, удельный вес РП колеблется от 10 до 20% и по частоте распространенности в некоторых регионах мира занимает 2-3 место. При этом установлено, что заболеваемость данной формой рака в Казахстане сравнительно высокая (12,8‰) в г.Алматы, по отношению к другим городам (М; ГЭОТАР-МЕД, 2007.).

Цель работы. Анализировать особенности распространения РП в г. Алматы

Материалы и методы. В процессе исследований обработаны данные всех зарегистрированных больных РП в г. Алматы с 1989 по 2000 гг. Приведены учетно-отчетные материалы онкологических учреждений г. Алматы, с впервые в жизни установленным и аргументированным диагнозом РП. Использованы статистические данные Департамента по делам статистики и демографии при Совете министров Республики Казахстана о численности, половозрастном и национальном составе населения по районам г. Алматы. При стандартизации показателей заболеваемости использован прямой метод и применен мировой состав населения.

Результаты и выводы. Всего за 1989-2000 гг. было зарегистрировано 1009 больных РП, что составляет 13,8% в структуре злокачественных опухолей ЖКТ, и по рангу занимает второе место. Из них мужчин – 536 (53,1%) и женщин – 473 (46,9%) больных РП. Заболеваемость РП всего населения – 7,4±0,8‰, а стандартизованные (мировой) – 6,6±0,8‰.

Распределение больных РП по возрастным группам имеет унимодальный характер роста с пиком в возрастной группе 70 лет и старше (48,1%). Средний возраст больных РП – 66,8±5,2 года, а в динамике увеличивается в сторону увеличения возраста.

Высокие показатели заболеваемости РП у городского населения установлена среди лиц 60-69 лет – 33,3±6,4‰, а также у лиц 50-59 лет – 13,1±3,6‰. Средний возраст больных из всего населения города был равен 66,8±5,2 год, в том числе мужчин – 65,0±6,4 и женщин – 68,9±7,1 года, и в динамике имели тенденции в сторону старения среднего возраста.

Интенсивные возрастные показатели заболеваемости РП по полу оказались неодинаковыми. Высокая максимальная заболеваемость РП у мужчин зарегистрирована среди лиц 70 лет и старше (99,8±19,2‰), которая в 1,8 раза выше, чем у женщин (55,5±11,4‰), аналогичные закономерности сохраняются в отношении других возрастных групп населения.

Заболеваемость РП у казахов – 9,8±1,7‰ (стандартизованные показатели – 8,7±1,5‰), у мужчин – 8,4±0,7‰, а у женщин – 11,1±1,0‰. Частота РП у казашек в 1,3 раза выше, чем у мужчин. Заболеваемость РП русского населения – 8,5±1,4‰ (стандартизованные – 14,6±1,7‰), у мужчин – 10,6±2,3‰, а у женщин – 6,4±1,8‰.

Таким образом, заболеваемость РП всего населения г.

Алматы остается высокой, но имеет тенденции к снижению. Уровень заболеваемости мужского населения в 1,3 раза выше, чем у женского. Выявлена высокая заболеваемость РП среди женщин-казашек. У русского населения заболеваемость имеет тенденции к росту, при этом частота у мужчин в 1,7 раза выше, чем женского населения.

Эти выявленные эпидемиологические особенности распространения РП среди жителей г.Алматы обусловлены демографическими, возрастными-половыми и этническими факторами населения. Полученные результаты позволяют проведение целенаправленной организации противораковой борьбы в г. Алматы.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В Г.АЛМАТЫ

ЗА 2005-2009 ГГ.

Кайдарова Д.Р., Шатковская О.В.,

Иманкулов А.Ж., Югай Т.А.

ГККП «Городской онкологический диспансер» г. Алматы

Онкологические заболевания остаются одной из самых актуальных проблем современной медицины Казахстана. В структуре смертности в г.Алматы онкологические заболевания на протяжении 5 последних лет занимают 3 место.

За период с 2005 по 2009 год отмечено незначительное снижение онкологической заболеваемости с 239,0 до 234,6 на 100 тысяч населения, однако данный показатель превышает среднереспубликанский по Казахстану на 29%. За счет улучшения ранней диагностики, снижения смертности и увеличения пятилетней выживаемости, вырос показатель болезненности с 1198,5 (15088 онкологических больных – 2005г.) до 1369,7, на 100 тыс. нас. (18806 – 2009г.).

За аналогичный период времени, смертность от онкологических заболеваний с тенденцией к снижению, с 124,1 до 120,1 на 100 тысяч населения, однако показатель одно-годовой летальности вырос с 25,4% в 2005 году до 26,7% в 2009 году.

Также отмечено улучшение показатели ранней диагностики с 46,2% в 2005 году до 55,1% в 2009 году и снижение доли запущенных форм злокачественных заболеваний в IV стадии с 9,8% до 7,9%.

За отчетный период показатель пятилетней выживаемости увеличился с 43,3% до 50,8%, он наиболее отчетливо характеризует работу онкологической службы г.Алматы и указывает на качество организации онкологической службы, т.е. качество лечения, охват лечением и диспансеризацией, а показатель ранней диагностики злокачественных новообразований в большей степени отражают деятельность врачей поликлиник и семейных амбулаторий.

Таким образом, только слаженная работа всех подразделений здравоохранения, позволяет улучшить все показатели онкологической службы и значительно улучшить качество жизни онкологических больных.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ЛЕГКОГО НАСЕЛЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

Бекмухамбетов Е.Ж., Сабыр К.К., Кузденбаев М.С.,

Муканов М.К., Туржанов К.Т.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР-болезней, МЦ ЗКГМУ им. М. Оспанова г.Актобе.

Актуальность. За последние десятилетия заболеваемость

раком легкого возросла во многих странах мира и в настоящее время для развитых государств является самой распространенной онкологической патологией у мужчин и остается одной из важнейших как медицинских, так и социально-экономических проблем. По статистическим данным ежегодно в мире регистрируется около 13 млн. новых случаев рака легкого, из них 60% приходится на развитые государства. Заболеваемость населения Республика Казахстан раком легкого также остается на высоком уровне.

Цель исследования. Изучение динамики заболеваемости и смертности от рака легкого населения Актыбинской области Республики Казахстан.

Материал и методы исследования. В анализе представлены данные заболеваемости и смертности от рака легкого населения Актыбинской области за 2005-2009 гг. При анализе полученных данных установлено, что рак легкого, не смотря на снижение заболеваемости в 2009 году 19,6 на 100 000 (РК 22,4) остается лидером среди злокачественных новообразований и занимает первое место. Не смотря на снижение уровня заболеваемости населения области, которая в 2009 году составила 19,6 на 100 000, тогда как в 2005 данный показатель равнялся 25,4, показатели смертности неуклонно растут, достигнув в 2009 году цифры 17,7 (2005 – 16,2). На высоких цифрах остаются показатели поздней диагностики, которые в в 2009 году составили 23,9%, тогда как в 2005 данный показатель равнялся 23,0%. Факторы риска для данной категории больных являются как эндогенные так и экзогенные, которые присутствуют в Актыбинской области. Частота заболеваемости у мужчин выше, чем у женщин.

Выводы. Таким образом, при анализе заболеваемости и смертности населения Актыбинской области необходимо отметить, что имеется снижение заболеваемости раком легкого, но в то же время остаются высокими и даже нарастают показатели поздней диагностики и смертности от данной патологии. В популяции вновь заболевших уровень выше у мужчин, чем у женщин.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ АКТЫБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

*Бекмухамбетов Е.Ж., Койшыбаев А.К., Симбатов Т.К.,
Уразбаева Н.И., Уразбаев О.Н.,*

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР-болезней, г.Актобе.

Актуальность. Анализ заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований играет огромное значение для определения потребностей населения страны в онкологической помощи и разработки перспективных планов технического и лекарственного обеспечения, подготовки кадров и планирования всего комплекса противораковых мероприятий. В связи с чем профилактика, раннее выявление и лечение злокачественных новообразований является одним из важных и сложных разделов современной медицины, которая определяется их сложностью, масштабностью и социальной значимостью.

Цель. Анализ динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Актыбинской области.

Материал и методы исследования. При анализе результатов исследования установлено, что в течении последних 5 лет отмечались своеобразные колебания в структуре заболеваемости. Если в 2007 году отмечалось снижение показателей заболеваемости, то в 2008 году отмечалось его повышение, а в 2009 году вновь снижение. В структуре онкопатологии лидирующую позицию занимает рак легкого, составляя 19,6 на 100 000 населения (РК 20,5), на втором месте рак молочной железы 18,7 (РК 20,5) и на 3 месте остается рак желудка,

заболеваемость которого равна 17,1 (РК 17,4). Наивысшие показатели заболеваемости отмечались в регионах области, где существуют экологические факторы риска. В структуре смертности 50% занимают рак легкого, желудка, пищевода и гемобластозы.

Выводы: 1. За последние 5 лет в структуре заболеваемости злокачественными заболеваниями по Актыбинской области отмечается снижение уровня заболеваемости на 8,9 % в 2009 году в сравнении с 2005 годом, показатель смертности снизился на 4,5 %.

2. При изучении факторов риска в регионах области с высоким уровнем заболеваемости присутствуют, как экзогенные, так и эндогенные, что говорит о необходимости проведения как первичных, так и вторичных профилактических мероприятий.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ СҮТ БЕЗІ РАГІ АУРУЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Жұмағалиев Д.Ж.

Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы диспансері

Мәселенің маңыздылығы: Қазіргі таңда, сүт безі рагі (СБР) әйелдердегі қатерлі ісік аурулары арасында алғашқы орындарды алады. Солтүстік Америка және Европа елдерінде әйелдер өлімінің 5/1-і СБР, ал Қазақстан Республикасында әйелдердегі кездесетін қатерлі ісік ауруларының құрылымында бірінші орынды СБР (19,5%) құрайды. Республика көлемінде жылына 3 мыңнан астам әйел алғаш рет сүт безі рагімен анықталса, оның 30 пайыздан астамы 3-4 сатысындағы асқынған түрімен тіркелуде. Өкініштісі, сырт көріністі мүшелер қатарына жатқанына қарамастан науқастардың 5 жыл өмір сүруі төмен пайызды көрсетуде. Сондықтан, қазіргі таңда ғылыми сарапталған жаңа әдістері сүт безінің ісік алды және ісік ауруларының алдын алуда маңызды орын алуы тиіс.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша сүт безі рагінің аурушандық жағдайын зерделеу

Зерттеу материалы: ОҚО 2005-2009 жылдар аралығында алғашқы рет сүт безі рагімен тіркеуге алу мәлімдемесіне және де арнайы қолданыстағы №35,7 есептік нысаналарға сүйене, тағы да қазіргі таңдағы онкологиядағы қолданыста жүрген жалпы санитарлық статистикалық әдістер негізінде көрсеткіштер алынған.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2009 жылы 2328 науқас қатерлі ісіктермен диспансерлік есепке алғаш рет алынған болса, соның ішінде сүт безі рагімен 258 әйел кісі тіркеліп, бірінші орынға шықты. Аурушандық деңгейі кейінгі жылдарда өсіп келеді, атап айтқанда 2005–2009 жылдар 100 000 халыққа шаққанда да 10,2 ден 11,0 өскен, ең жоғарғы көрсеткіш облыс көлемінде Арыс ауданында 14,4, Шымкент қаласында 13,8, Мақтарал ауданында 12,5, Сарыағаш ауданында 12,0 болған, ал төмен көрсеткіштер Ордабасы ауданында 5,3, Байдыбек ауданында 5,5, Қазығұрт ауданында 5,9 болған. Бұл айырмашылық кенттенуі жоғары елді мекендерде байқалуда.

Сүт безі рагімен анықталған әйелдерді жасына қарап бөлсе, онда 2005 жылы 15-50 жас аралығында 119 науқас 49,5 пайыз, ал 2009 жылы 99 науқас 38,3 пайыз, бұл да осы жастағылар аралығында 11,2 пайызға азайған. Ал 2005 жылы 50 жастан жоғары 121 науқас 50,4 пайыз, 2009 жылы 159 науқас 61,6 пайыз, демек 11,2 пайызға өскен.

Алғашқы ерте кезеңде (1-2 сатысында) анықталуы 2005 жылы 70,0 пайыздан 2009 жылы 79,8 пайызға өскен. Бұл елімізде жүріп жатқан скринингті профилактикалық тексерудің оң нәтижесі, атап айтқанда профилактикалық тексеру кезеңінде 2005 жылы 4,9 пайыз сүт безі рагі анықталса, ал 2009 жылы 10,3 пайыз болған. Ал асқынған түрі 2005 жылы

22,1 пайыздан, 2009 жылы 19,3 пайызға төмендеген.

Ауырғыштығы ОҚО бойынша 2005 жылы 23,0 (100 000 халыққа шаққанда) болса, ал 2009 жылы 28,9 өскен. Бір жылдық өлім жатыр мойны рагінен 2005 жылы 5,4 пайыздан 2009 жылы 12,7 пайызға өскен, әліде жоғары деңгейде. Сондықтан сүт безі рагінен жалпы өлімде азаймай отыр, бұл көрсеткіш 2005 жылы 100 000 халыққа шаққанда 3,3 болса, ал 2009 жылы 5,4 болған.

Науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі 2005 жылы 385 науқас 36,8 пайыз болса, ал 2009 жылы 635 науқас 40,0 пайызға өскен, бірақ бұл төмен көрсеткіш.

Тұжырым: Қорыта айтқанда, ОҚО бойынша 50 жастан жоғары әйелдер арасында кеңінен таралуы заңдылық болғанымен, сапалы көрсеткіштердің жақсарғанына қарамастан, бірінші орынға шығуы, әліде болса өлім саны көптігі, науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі төмендігі ойландырады. Бұл бастапқы медициналық санитарлық көмек деңгейінде сүт безі рагіне соқтыратын ауруларды алдын ала анықтау, емдеу, сауықтыруды және оны алғашқы кезеңінде анықтау өз деңгейінде жүргізгенде ғана, осы ауруды және өлімді азайтуға, 5 жыл және одан артық өмір сүруін арттыруға мүмкіндік туындайды деп ойлаймыз. Сондықтан ҚР ДСМ № 607 15.10.07 ж. және № 685 10.11.09 ж. бұйрықтарының іске асырылуы, бұл өмір талабы.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧКИ В ЮЖНО- КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

*Джумағалиев Д.Д., Оспанова Г.А., Джаханова Л.А.,
Тажимаева К.Н., Асанова К.К.*

Южно-казахстанской областной онкодиспансер

Актуальность проблемы: В мире ежегодно регистрируется около 190 000 новых случаев рака почки и около 90 000 смертей от данного заболевания. При этом заболеваемость колеблется примерно от 2,0 до 12,0 на 100 000 населения, что составляет 1-3% всех злокачественных новообразований. Более высокие показатели характерны для развитых стран Америки и Европы, низкие – для Азии, включая Японию. Заболеваемость раком почки в России в 2006 году составила 11,25 на 100 000 населения. В 2008 году в Республике Казахстан на учет взято 820 больных раком почки с впервые установленным диагнозом, что составляет 5,2 на 100 000 населения.

Злокачественное новообразование почки является заболеванием, которое долгое время может протекать бессимптомно, что приводит к позднему обращению за медицинской помощью и негативно сказывается на результатах лечения.

Цель исследования: изучение состояния заболеваемости раком почки (РП) в Южно-Казахстанской области (ЮКО).

Материалы исследования. В исследование включены больные с раком почки, состоящие на диспансерном учете в областном онкологическом диспансере ЮКО с 2005 по 2009 гг.

Результаты: В ЮКО в 2005 году на учет взято 2345 больных со злокачественными новообразованиями различных локализаций, из них 53 больных РП (2,2%). Уровень заболеваемости раком почки повысился с 2,2% в 2005 году до 2,7% в 2009 году. Выявленных больных с раком почки в работоспособном возрасте до 60 лет в 2005 году 18 больных 33,9%, а в 2009 году 41 больных 64,06%.

Показатели болезненности по ЮКО в динамике с 2005 г. имеют тенденцию к увеличению (от 7,0 на 100 000 населения в 2005 году, 7,9 в 2006 году и в 2009 году 10,6).

Количество выявленных случаев рака почки в ранних стадиях повысилось с 33,9% в 2005 году и 40,4% в 2006 году до 56,2% в 2009 году.

Динамика показателей выявленных больных с запущенными стадиями рака почки имеет тенденцию к снижению с 20,7% в 2005 году до 6,2 в 2009 году.

Снижается показатель одногодичной летальности по 2006-2007 годами, когда этот показатель были 36,1% - 47,3%, а в 2009 году снизился до 24,0%, но смертность не снижается (в 2006 году 1,3 на 100 000 населения, а в 2009 году 1,2).

В ЮКО повысился показатель пятилетней выживаемости от 31,3% в 2005 году до 39,2% в 2009 году.

Выводы. Несмотря на незначительные успехи, не снижается смертность и увеличивается доля больных в работоспособном возрасте. Поэтому в целях профилактики рака почки следует вести пропаганду здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками, своевременно лечить неопухолевые и хронические заболевания почек. Кроме этого, считаем целесообразным проводить ультразвуковое исследование почек у практически здоровых людей после 40 лет, поскольку появление симптомов свидетельствует чаще всего о запущенности опухолевого процесса. Также следует проводить динамическое наблюдение за пациентами из групп повышенного онкологического риска.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ СҮТ БЕЗІ РАГІ АУРУЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

*Жұмағалиев Д.Ж., Орманов Н.К.,
Бимағанбетова Н.Б., Кабылов А.Б.*

*Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы
диспансері*

Мәселенің маңыздылығы: Халықаралық ракты зерттеу (IARC) агентінің мәлімдемесі бойынша дүниежүзінде 1400 әйелдер күн сайын жатыр мойны рагіне шалдыққандығын білсе, ал шамамен 750 осы дерттен қайтыс болады. Бұл әр 2 минутта 1 әйел қайтыс болатындығын көрсетеді. Жыл сайын дүниежүзінде 500 000 жаңадан жатыр мойны рагі анықталса, ал 270 000 астамы қайтыс болады. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдемесі бойынша 2050 жылы болжамен 1000 000 жатыр мойны рагімен тіркеледі, онда шамамен 600 000 әйел қайтыс болады. Өйткені, іргесін жаңа қалап келе-жатқан мемлекеттерде, осы аурудан өлім 80 пайыздан кем болмай отыр.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша жатыр мойны рагінің аурушандық жағдайын зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО қатерлі ісікке қарсы диспансерінің 2005-2009 ж. аралығындағы жатыр мойны рагімен диспансерлік есептегі науқастар зерттелген.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2009 жылы 2328 науқас қатерлі ісіктермен диспансерлік есепке алғаш рет алынған болса, соның ішінде жатыр мойны рагімен 135 әйел кісі тіркелген. Аурушандық деңгейі кейінгі жылдарда өсіп келеді, атап айтқанда 2005–2009 жылдар аралығында 4,6 пайыздан 5,7 пайызға, ал 100 000 халыққа шаққанда да 5,0 ден 5,7 өскен. Жатыр мойны рагімен анықталған әйелдерді жасына қарап бөлсе, онда 2005 жылы 15-50 жас аралығында 50 науқас 45,8 пайыз, ал 2009 жылы 96 науқас 71,1 пайыз, бұл да осы жастағылар аралығында да 25,3 пайызға өскендігін көрсетеді.

Алғашқы ерте кезеңде (1-2 сатысында) анықталуы 2006 жылы 76,8 пайыздан 2009 жылы 87,4 пайызға өскен. Бұл елімізде жүріп жатқан скринингті профилактикалық тексерудің оң нәтижесі, атап айтқанда профилактикалық тексеру кезеңінде 2006 жылы 4,6 пайыз жатыр мойны рагі анықталса, ал 2009 жылы 10,3 пайыз болған. Ал асқынған түрі 2006 жылы 23,1 пайыздан, 2009 жылы 12,4 пайызға төмендеген.

Ауырғыштығы ОҚО бойынша 2005 жылы 23,0 (100 000 халыққа шаққанда) болса, ал 2009 жылы 28,9 өскен. Бір жылдық өлім жатыр мойны рагінен 2006 жылы 32,6 пайыздан 2009 жылы 21,2 пайызға азайғанына қарамастан, әліде жоғары

деңгейде. Сондықтан жатыр мойны рагінен жалпы өлімде азаймай отыр, бұл көрсеткіш 2009 жылы 100 000 халыққа шаққанда 3,6 болса, ал 2005 жылы 2,8 болған.

Науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі 2005 жылы 209 науқас 41,7 пайыз болса, ал 2009 жылы 356 науқас 52,1 пайызға өскен.

Тұжырым: Қорыта айтқанда, осы жатыр мойны рагі ОҚО бойынша туу жасындағы әйелдер арасында кеңінен таралуда, демек аурушандығы да өсіп келеді. Сапалы көрсеткіштердің жақсарғанына қарамастан, әліде болса өлім саны көптеу, бұл бастапқы медициналық санитарлық көмек деңгейінде жатыр мойны рагіне соқтыратын ауруларды алдын ала анықтау, емдеу, сауықтыруды және оны алғашқы кезеңінде анықтау өз деңгейінде жүргізгенде ғана, осы ауруды және өлімді азайтуға мүмкіндік туындайды деп ойлаймыз. Сондықтан ҚР ДСМ № 607 15.10.07 ж және де №685 10.11.09 ж бұйрықтарының іске асырылуы, бұл өмір талабы.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Темирғалиев Г.А.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: рак щитовидной железы - наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль эндокринных органов. Диагностика и лечение пациентов по поводу рака щитовидной железы является весьма вариabельным, а определение тактики лечения и дальнейшего ведения и наблюдения больного иногда представляет большую сложность.

Цель работы: анализ и изучение статистических показателей рака щитовидной железы в Павлодарской области.

Материалы и методы: статистический анализ учётных и отчётных форм.

Рак щитовидной железы составляет в среднем 1-1,5% от всех злокачественных новообразований, однако отмечается тенденция к увеличению частоты данного заболевания особенно в зонах мультифакторного загрязнения окружающей среды.

Болезнь часто поражает людей молодого, трудоспособного возраста. В большинстве случаев щитовидная железа поражается дифференциальными формами опухоли, при правильном лечении которых врачи могут добиваться вполне удовлетворительных результатов. Однако больше раком щитовидной железы часто обращаются к врачам различных специальностей (хирургам, эндокринологам, терапевтам, ЛОР), которые не знают особенностей и своеобразие клинического лечения данной патологии, имеющей особые биологические свойства. В связи с этим применяются различные, а подчас неадекватные данному заболеванию методы диагностики и лечения. Нами проанализированы амбулаторные карты больных раком щитовидной железы взятых на диспансерный учет в Павлодарском онкодиспансере за период с 2002-2005гг. В структуре онкологического заболевания данная патология в Павлодарской области занимает 18 место (1,5%). В динамике отмечается прирост заболевания на 56% с 23 случаев в 2002 до 36 случаев в 2005г. соотношение женщин и мужчин составило 8:1. Подъем заболеваемости наступает на 4 десятилетия. В области пик заболеваемости приходится на возраст 50-59 лет. Частота РЩЖ от общего числа хирургической патологии этого органа составило в Павлодарской области 6,8%, в Восточно-казахстанской области 8,7%. Чаще болеют городские жители (70%), люди трудоспособного возраста (87%), что, скорее всего связано с большей численностью населения в городах и состоянием окружающей

среды, среди которого особое место занимает ионизирующее излучение, обладающее blastomatoznым действием на щитовидную железу.

При морфологическом изучении операционного материала выявлено, что наиболее часто встречается дифференцированная форма рака: папиллярный рак- 69,2%; фолликулярный рак-26,9%; смешанная форма-3,8%. Одногодичная выживаемость после радикального хирургического лечения -98,3%. Пятилетняя выживаемость 65,5%, связана с тем, что значительное количество больных оперируется в неонкологических отделениях, что приводит к неадекватному по объему операции (т.е. энуклеация узла, резекция доли, гемитиреоидэктомия без перешейка и т.д.).

Результаты и выводы: разработка и внедрение в практику новых методов диагностики и усовершенствование существующих методов лечения рака щитовидной железы является актуальной задачей онкологии.

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА 2000-2009 ГГ.

Жумадуллаев Б.М.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы

В сравнении с частотой других заболеваний детского возраста, злокачественные новообразования (ЗН) у детей встречаются редко, однако по своей значимости в структуре детской инвалидизации и смертности эти заболевания занимают одно из первых мест.

Заболеваемость детей ЗН в различных странах приблизительно одинаковы, но бывают и исключения. Частота возникновения злокачественных опухолей относительно небольшая по сравнению с взрослыми, так в США ежегодно заболевают около 8000 детей, а в странах Европы около 21000, в России более 7000, в республике Казахстан более 300 детей до 15 лет ежегодно.

В общей структуре заболеваемости всего населения на долю заболеваемости ЗН в детском возрасте в мире колеблется от 0,5 до 4,0%.

За период 2000-2009 гг. в РК было выявлено 2956 новых случаев ЗН у детей. Заболеваемость детей с ЗН в РК на 100000 детского населения в 2000 году составила - 7,4 (303 детей), в 2005 году - 8,4 (310 детей), в 2009 году - 7,5 (283 детей). Контингент в 2000 году - 568, в 2005 году - 948, в 2009 году - 1114 детей.

5-летняя выживаемость детей от ЗН составила в 2000 году - 25,4%, в 2005 году - 25,5%, в 2009 году - 29,7%.

Одногодичная летальность детей от ЗН составили в 2000 году - 18,5%, в 2005 году - 25,0%, в 2009 году - 24,4%.

Удельный вес онкологических больных детей с IV стадией заболевания составили в 2000 году - 9,2%, в 2005 году - 8,2% и в 2009 году - 7,4%.

Смертность от ЗН на 100000 детского населения в 2000 году составила - 3,0, в 2005 году - 3,7, в 2009 году - 3,8.

В структуре онкологической заболеваемости детского населения в РК, в 2009 году солидные опухоли составили 66,7%, лейкозы - 22,5% и лимфомы - 10,9%. Первое место занимают лейкозы (до 25%), далее следует опухоли ЦНС - 20,2%, лимфомы - до 11,0%, опухоли мягких тканей - 9,7%, опухоли почек и костей - по 7,2%, ретинобластома - 5,8%, нейробластома - 3,4%, и другие редкие опухоли - 2,2%.

За период 2000-2009 гг. заболеваемость детей ЗН в Республике Казахстан характеризуется стабильностью и отмечается прирост контингентов.

**ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ПИЩЕВОДА В
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2000-2009 ГОДЫ)***Кравчук В.А., Сулейменов М.К.**КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: рак пищевода является одним из наиболее часто встречающихся и тяжело протекающих заболеваний. В Республике Казахстан заболеваемость рака пищевода так же неоднородна, Павлодарская область входит в число регионов с низкой заболеваемостью, но из-за этого проблема не становится менее актуальной.

Цель исследования: анализ и изучение статистических показателей рака легкого в Павлодарской области в 1990-2009 годах.

Материалы и методы исследования: статистические отчеты КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», конъюнктурный обзор деятельности.

За период с 1970 по 1990 годы заболеваемость пищевода в Павлодарской области снизилась почти в 2 раза с 19,4 до 9,7. В 90-х годах прошлого столетия заболеваемость была стабильной, хотя подвергалась некоторым колебаниям, но их можно считать не существенными. Заболеваемость в разные годы подвергалась колебаниям от 6,3 до 10,4, стандартизованный показатель в 2000 году составил 7,8, а к концу 10-летия 7,3. Достоверно изменились соотношения стадий, так I-II стадия увеличилась с 20,5 до 34,8, а IV стадия уменьшилась с 39,7 до 15,2. Смертность при этом снизилась незначительно с 7,0 до 6,0. Что объясняется высоким уровнем пациентов старших возрастов. По нашим наблюдениям доля больных в возрасте до 60 лет составила 24,2%, 60-64 года – 20,2%, 65-69 лет – 15,2%, старше 70 лет – 40,4%, стандартизованный показатель составил соответственно до 60 лет – 2,24, 60-64 года – 34,4, 65-69 лет – 47,2, а в возрасте старше 70 лет – 79,9. Практически все онкологи отмечают, что рак пищевода это болезнь старческого возраста.

Болезненность за последние 10 лет практически не изменялась и составила 13. Процент верификации за счет увеличения финансирования здравоохранения, внедрения стандартов диагностики и лечения увеличился с 75 до 86%. Увеличился несколько процент получивших специальное лечение с 34,5 до 41,8%. Снизилась годовая летальность с 66 до 63,4% (в связи с малыми цифрами проведен анализ стандартизованных показателей).

Результаты и выводы: в Павлодарской области одна из самых низких заболеваемости злокачественными опухолями пищевода. Отмечается такая же как и в других регионах высокая смертность от рака пищевода. Повышение процента населения старших возрастов, ослабление первичной медико-санитарной помощи привели к росту запущенности. Но с внедрением протоколов диагностики и лечения, улучшением финансирования здравоохранения отмечаются и некоторые положительные подвижки (увеличился процент верификации, процент получивших специальное лечение, несколько снизилась годовая летальность).

**О ГЕНЕЗЕ РАКА КОЖИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
КАЗАХСТАНА***Каримов М.А.**КазНИИОур, Алматы*

Ультрафиолетовая часть солнечного спектра как этиологический фактор рака кожи признана подавляющим большинством сообщества онкологов мира. По нашему мнению, для возникновения рака кожи этого не всегда достаточно. Так, например, чем объяснить, что заболеваемость раком кожи в Южно-Казахстанской области (ЮКО), где изобилие солнца, была равна 10,3‰ в 2004 г, снизилась до 7,3‰ в 2008 г, тогда как в Северо-Казахстанской области (СКО), где солнца

мало, она в этот же период составляла 19,4-: 18,7‰? Солнечных дней и долгота светового дня в 2 раза меньше, а заболеваемости раком кожи в 2 раза больше. Далее в одной из областей Южного региона - Жамбылской : за эти годы заболеваемость раком кожи составляла 11,7 - 8,8‰, тогда как в Павлодарской области, расположенной почти на уровне СКО, она была равна 24,3 - 27,4‰, т.е. 2-3 раза больше. Ведь солнца в Жамбылской области гораздо больше, чем в Павлодарской. Все эти области «перешеголяла» Восточно-Казахстанская область (ВКО), где заболеваемость раком кожи была самой высокой в Республике и составляла 44,8 - 36,0‰, т.е. она (заболеваемость) была в 4-5 раз выше, чем в южных регионах. Отрицаем ли мы роль ультрафиолетовой радиации? Отнюдь. Ведь, в ВКО, как теперь уже известно, производились «урановые таблетки», а это дополнительный лучевой фактор. Доказательством служит более высокий показатель заболеваемости раком кожи в г.Усть-Каменогорск (80,0- 65,7‰), где производилось «Урановое топливо». В воде оз.Зайсан, Зайсанского и Ульбинского водохранилищ, реки Иртыш, Ульба, Уба, Граматуха, Шарафка и др., выявлено высокое содержание бенз(а)пирена (БП)- от 0,010мкг/л до 0,036 мкг/л, что соответствует 2-7 ПДК и тяжелых металлов (ТМ) - кадмия, никеля, свинца, в дозах превышающих ПДК в 2-10 раз. Население купается в этой воде. Следовательно, возможно суммационное, синергическое действие трех канцерогенов. Как нам представляется, эта мысль подтверждается фактом повышенной заболеваемости раком кожи в Павлодарской области, где она ниже, чем в ВКО, но выше, чем в Жамбылской и ЮКО. В Павлодарской области нет «урановых таблеток», но вода Иртыша больше загрязнена канцерогенами, выявлено загрязнение пляжей, где купаются люди. Отмечается загрязнение этими канцерогенами и подземных, грунтовых вод. Содержание БП порой превышало ПДК в 60-70 раз и содержание ТМ - Cd, Ni, Pb, превышало ПДК в 17-23 раза.

На заболеваемость раком кожи могло сказаться и иметь определенное значение также число населения разных национальностей. В ЮКО и Жамбылской области казахского населения больше. Казахи, веками проживающие в этих регионах, адаптировались к действию солнечных лучей, у них выработалась определенная толерантность к канцерогенному действию ультрафиолетовой части солнечного спектра. Это обстоятельство нельзя не учитывать. Однако в Восточном регионе ВКО число казахов не больше, чем в Павлодарской области, а заболеваемость раком кожи выше. Не изучен вопрос, какой из этих факторов играет роль инициатора канцерогенеза, а какой-протора. Мнение, что свинец может играть роль протора при комбинированном действии на легочный эпителий с другими канцерогенами может иметь место и при действии на эпителий кожи.

**СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ И ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В РАЙОНАХ СЕВ.-КАЗ. ОБЛАСТИ***Абдримов Е.Г., Байясунов Э.А., Магзумов А.Б.**КГКП «Областной онкологический диспансер», г.**Петропавловск*

Актуальность. Медиана пика онкозаболеваемости в России в период 1998 - 2008 г. г. приходилась на возраст 61 - 63 лет, а в Европе 65 - 69 лет. По данным ВОЗ, если в структуре населения лица 60 лет и старше превышает 7 %, тогда страна относится со стареющим населением и нужно ожидать роста онкозаболеваемости.

Цель. Изучить структуру населения области в разрезе районов в контексте с уровнем онкозаболеваемости в этих регионах в 2005 - 2009 г. г.

Материалы и методы. Представлены средняя заболеваемость ЗНО (медиана) в 2005 - 2009 годах в разрезе районов, а также определены доля лиц 60 лет и старше в структуре

населения области в выше указанный период. В таблице приведены показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в разрезе районов Сев.-Каз. обл. и стандартизованные показатели.

Онкозаболеваемость и структура населения области в разрезе районов

	Средний показатель (медиана) за 2005-2009 г.г.		
Наименование районов	Онкозабол. на 100 тыс. населения («грубый» показатель)	Стандартиз. показатель заболеваемости	Доля лиц 60 лет и старше в структуре населения в %
Айыртауский	163,6	130,5	13,9
Ақжарский	107,3	107,6	9,6
Аққайынский	243,8	195,5	13,35
Есильский	237,4	188,2	13,85
Жамбылский	194,0	157,9	12,81
М. Жумабаев ЕЛ	208,4	161,9	14,0
Қызылжарский	230,5	180,9	14,6
	239,3	180,9	14,2
Г. Мусрепова	162,1	133,1	12,15
Тайышшинский	168,7	145,3	11,98
Тимирязевский	151,8	159,8	10,55
Уалихановский	93,0	104,6	8,52
Шал - Ақына	199,5	152,0	14,9
г. Петропавловск	373,9	249,7	15,45
Сев.-Каз. область	245,1	160,5	13,2

Результаты. По уровню заболеваемости ЗНО районы области были разделены на 3 группы. В группу районов с высокой онкозаболеваемостью, т. е. - 200 ‰ и выше вошли г. Петропавловска и пять районов (Аққайынский, Есильский, М.Жумабаева, Қызылжарский, Мамлютский), а со средним от 160 ‰ до 200 ‰ (Г.Мусрепова, Тайышшинский, Жамбылский, Айыртауский, Шал - Ақынекий) и низкими показателями ниже 160 ‰ (Уалихановский, Ақжарский, Тимирязевский). В группе районов с относительно низким уровнем онкозаболеваемости наблюдалась более низкая доля лиц 60 лет и старше (8,52%, 9,6% и 10,5% соответственно), что ниже среднеобластного показателя на 28,1 %. В районах с высокими уровнями онкозаболеваемости отмечается и более высокая доля лиц пожилого возраста (13,35%, 13,85%, 14,0%, 14,6%, 14,2% соответственно) или средний их показатель выше областного на 8,4%.

Выводы. В области доля лиц старше 60 лет превышает рекомендуемой ВОЗ 7 ‰ почти в 2 раз. В районах с высоким уровнем онкозаболеваемости в структуре населения доля лиц старше 60 лет превышает областной показатель на 8,4%, а в районах относительно низким уровнем онкозаболеваемости, доля пожилых людей ниже областного показателя на 28,1%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ПИЩЕВОДА В КАЗАХСТАНЕ

Игисинов С.И., Кайдаров Б.К., Есенкулов А.Е.
Каз. НМУ им с.Д. Асфендиярова, г. Алматы

Рак пищевода (РП) является одним из самых распространенных злокачественных заболеваний в земном шаре, особенно характерно для Средней Азии и Казахстана, что требует проведение дальнейших углубленных эпидемиологических исследований и поэтому данная работа посвящена изучению региональной особенности рака данной патологии

в республике. Материалом исследования послужили данные за 1989-2006 годы, касающиеся РП, со использованием общепринятых методов санитарной статистики. РП в Казахстане в среднем составил 15,2‰, и в динамике снизился с 15,5‰ до 9,3‰, а по отдельным регионам распространено неравномерно. В Восточном регионе заболеваемость РП снизилась с 10,1‰ (1996 г.) до 9,2‰ в 2006 году, аналогично и в Северном регионе - с 9,6‰ до 7,8‰, соответственно. Для Южного региона характерным оказался, то, что во всех областях РП была выше и самая высокая - в Кызылординской (46,0‰) области, что в 3 раза выше, чем по республике, однако в динамике РП снижался с 41,8‰ до 24,1‰. В Западном регионе - самый низкий РП установлено в Западно-Казахстанской (10,4‰), а в остальных - в Актыбинской (19,7‰) и Мангыстауской (23,9‰) и Атырауской (35,6‰) областях были высокими, чем по республике. Самый высокий показатель РП выявлено в Атырауской области, где частота рака в 2,3 раза были выше по сравнению с данными по Казахстану. Установлено, что ниже среднереспубликанских показателей заболеваемости РП (15,2‰), располагались 8 областей и 2 городов с частотой с 5,6 до 12,1‰, а выше - 9 областей с 17,0 до 46,0‰. Причем первое место занимает Кызылординская (46,0‰), второе - Атырауская (35,6‰) и третье - Мангыстауская (23,9‰) области. За этот период РП в республике снизился на 5,7‰ больных или на 36,8%, а темп снижения оказались ощутимой ($T = -0,32\%$) и снижение угла тренды заболеваемости $tg(a)$ приближается к 30°, что свидетельствует о истинном снижении РП в Казахстане. Подобный факт, обусловлено, с тем, что социально-экономическое положение населения улучшилось и изменилась экологическая ситуация в стране, в связи с ликвидацией Семипалатинских и Азгирских ядерных полигонов. А так же изменением характера питания с меньшим содержанием предшественников нитрозаминов (нитритов, нитратов и аммиака) и др. Кроме того, изменилась возрастная состав населения республики, уменьшился когорты людей, подверженных воздействию продуктами ядерных взрывов, проведенных в Казахстане. Выявленное региональное особенности распространение РП на территории Казахстана, позволяет определить приоритетное направление по проблеме РП и позволять организовать целенаправленных противо-раковых мер в отдельных регионах Казахстана.

ДИНАМИКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 50 ЛЕТ

В.Н. Полешко

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: в течение последних десятилетий отмечается неуклонный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями в Павлодарской области. С точки зрения эпидемиологии - рак нельзя рассматривать как отдельное заболевание, здесь необходимо отметить наличие связей между раком и широким спектром социально-экономических особенностей региона, экологических факторов, наследственности, бытовых привычек населения.

Цель работы: проведение анализа онкологической заболеваемости и смертности злокачественными новообразованиями в Павлодарской области за последние 50 лет.

Материалы и методы: статистические отчеты за 1958 - 2008 годы.

Показатель заболеваемости в области вырос с 88,0 на 100000 нас. в 1958г. до 265,3 в 2008г. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Казахстане в 1958 году составила 76,5 на 100.000 населения. Ежегодный прирост заболеваемости 4,1%. Увеличение показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения

Павлодарской области за последние 50 лет в 3 раза прежде всего следует объяснить улучшением регистрации и учета онкологических больных, совершенствованием работы областного онкологического диспансера, увеличением средней продолжительности жизни населения. Ежегодный прирост составил 6,2%. Однако необходимо отметить и действительный рост частоты онкологических заболеваний, почти по всем локализациям. Заметный прирост заболеваемости значительно повлиял на структуру заболеваемости злокачественными новообразованиями в области. Последние 15 лет на первом месте находится рак легкого, рак молочной железы и рак желудка занимают с 1998 года второе – третье место. На четвертом месте стоит рак кожи. Число заболевших раком достигает своего максимума у обоих полов примерно в возрасте 60 - 69 лет. Смертность от злокачественных новообразований имеет неуклонный рост. В 1958г. показатель составил 46,7 на 100000 нас., в 2008г. – 162,9. Ежегодный прирост 5,1%.

Выводы и результаты: представленный анализ заболеваемости и смертности злокачественными новообразованиями Павлодарской области за 50 лет позволяет сделать следующие выводы:

1. Увеличение заболеваемости злокачественными новообразованиями по Павлодарской области в три раза связано не только с положительными сдвигами в организации онкологической помощи, но также и значительным истинным ростом заболеваемости за этот период.
2. Прошло значительное изменение структуры заболеваемости.
3. Наиболее подверженный раку возраст 60 - 69 лет, который с 1990 годов одинаково часто поражает оба пола.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В Г. АСТАНА

Тулетаев М.Е., Жумагазин Ж.Д.,
Мустафина Б.К., Жуков Ю.В.

Городской онкологический диспансер г. Астана

Актуальность проблемы: Из 1247 случаев онкологических заболеваний, выявленных в 2009г на долю онкоурологических приходится 115 (9,2%). Количество больных с каждым годом возрастает. Ранняя диагностика – важнейшее условие, позволяющее улучшить результаты лечения.

Цель работы: проанализировать статистические данные по онкоурологическим заболеваниям в г. Астана за 2009г.

Материалы и методы: В 2009г было выявлено 49 случаев рака почки, что составило 41,7% от всех онкоурологических заболеваний. Мужчин было 28, женщин 21. I- II ст. заболевания установлена у 21 пациента, III ст. у 21, IV ст. - у 6. В возрасте 40-60 лет было 15 больных (30,6%), старше 60-30 (61,2%). 16 (32,6%) поступили в экстренном порядке с явлениями макрогематурии, тампонады мочевого пузыря, клиникой почечной колики, острого пиелонефрита. Заболеваемость по г. Астана-7,2 на 100 тыс, смертность-2,4 на 100 тыс. пятилетняя выживаемость 38%.

В 2009г. рак мочевого пузыря был выявлен у 23 (20%) пациентов. Мужчин было 17, женщин 6. I-II ст. установлена у 19, III ст. у 4 пациентов. В возрасте 40-60 лет-8 больных, старше 60 лет-15. 8(34,8%), пациентов поступили в экстренном порядке с явлениями макрогематурии и тампонады мочевого пузыря. Заболеваемость по г. Астане 4,5 на 10 тыс, смертность 1,0 на 100 тыс., пятилетняя выживаемость 44,6%.

Рак яичка выявлен в 2009г выявлен в 7 случаях(6%). Возраст всех больных до 30 лет. I-II-я стадия заболевания установлена 6 больным, IV- одному. Заболеваемость по г. Астане 1,2 на 10 тыс. Пятилетняя выживаемость 44,8%

Рак предстательной железы в 2009г выявлен у 40 пациентов- (34,7%) от всех онкоурологических заболеваний. I-II ст. установлена у 18 пациентов, III ст. - у 16, IV-у 4-х. 36 (90%)

больных были старше 60 лет. 14(35%) пациентов поступили в экстренном порядке с явлениями ОЗМ. Заболеваемость по г. Астане-3,2 на 100 тыс, смертность-1,6 на 100 тыс, пятилетняя выживаемость 27,5%

Результаты и выводы:

1. 33% онкоурологических больных были госпитализированы в экстренном порядке.
2. Симптомы, позволяющие заподозрить онкоурологическое заболевание отмечались на протяжении от нескольких месяцев до года и более у большинства больных
3. С целью улучшения ранней диагностики онкоурологических заболеваний необходимо повышать санитарную грамотность населения.
4. Для раннего выявления рака предстательной железы мужчинам старше 50 лет следует рекомендовать ежегодное определение уровня ПСА.
5. По данным литературы УЗИ позволяет поставить диагноз рака почки в 75-93% случаев поэтому это обследование должно быть обязательным при проведении профосмотров.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДА ҚАТЕРЛІ ІСІКТЕРМЕН КҮРЕСУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ

Толеутайұлы К.

Облыстық онкология орталығы, Қызылорда

Соңғы жылдары қатерлі ісіктермен аурушандықтың және өлім-жітімнің құрылымының өзгеруі орын алуда. Оның өзі біріншіден денсаулық сақтау саласының жеңісіне, екіншіден халықтың тұрмысының жақсаруына және адам жасының орташа ұзақтығының ұзаруына тікелей байланысты.

Мақсаты 2005-2009 жж. аралығында қатерлі ісік аурушандығына баға беру, оның бағытын анықтау.

Материалдары және әдістері. Соңғы жылдары онкология мекемелерін республикалық және жергілікті бюджеттерден құрал-саймандар алынды, медициналық көмектің сапасымен мәдениетін арттыруға жағдай жасалды.

Онкология орталығында қазіргі - 4398 науқас есепте тұрады, оны 100 000 тұрғынға есептегенде 685,5. Жыл сайын 5 жылдан астам онкологиялық науқастың өмір сүруі артуда (49,6% ; ҚР – 50,2%).

Қатерлі ісіктермен науқастардың аздап болса да төмендеу тенденциясы байқалады. Атап айтқанда, 2005 жылы 100 000 тұрғынға 154,5 болса, 2009 жылы 143,3 құрайды, яғни 7,2% төмендеп отыр (ҚР – 182,6%ооо).

Қатерлі ісік ауруларын жынысына және жасына қарай талдағанда әйелдердің аурушандығы 76,8%ооо, ер адамдардың – 67,5%ооо.

Соңғы жылдары қатерлі ісікпен аурушандықты жынысына және жасына қарай талдағанда нақты заңдылық байқалады: әйелдер мен ер адамдар арасында өңеш және өкпе қатерлі ісіктерінің төмендеуі орын алса, әйелдер мен ер адамдар арасында асқазан және лимфа, қан тамырлары жүйесінің қатерлі дерттерінің ұлғаю тенденциясы орын алып отыр.

Сонымен қатар әйелдер арасында сүт безі және жатыр мойны қатерлі ісіктері көбеюде. Ол елімізде жүріп жатқан профилактикалық тексерудің, яғни маммографиялық және цитологиялық тексерулердің нәтижесі.

Қатерлі ісік дертімен ауырған адамдардың құрылымында бірінші орынға- асқазан(12,4%) шықса, екінші-өңеш (12,1%), үшінші- өкпе (11,9%), төртінші орында сүт безі қатерлі ісігі (9,2%).

Әйелдер арасында онкологиялық аурулардың құрлымын зерттегенде сүт безі қатерлі ісігі бірінші орынға шығып отыр (16,8%). Сүт безі қатерлі ісігімен ауырған әйелдердің жас ерекшеліктерін талдағанда жиі кездесуі 81,2%ооо 60-69 жас аралығында.

Соңғы 5 жылда өңеш қатерлі ісігі 100 000 тұрғынға есептегенде облыс көлемінде 25,9%ооо –дан 17,3%ооо –ке, яғни

33,2 % төмендеп отыр. Оның себебі біріншіден қатерлі ісік алдындағы ауруларды емдеу жақсарса, екіншіден халықтың әлеуметтік жағдайы, сонымен қатар таза сумен қамтамасыз ету жақсаруда.

Соңғы бес жыл көлемінде қатерлі ісік салдарынан өлім-жітім 100 000 тұрғынға есптегенде 110,9-дан 105,6 дейін төмендеп отыр.

Жыл сайын қатерлі ісіктерді I-II сатысында анықтау жақсаруда. Мысалы, 2009 ж. қатерлі ісікпен ауырған науқастардың 40,9% I-II сатысында анықталса, ол көрсеткіш 2005 жылы 36,4% құраған болатын.

Жаңалықтарды енгізу: Папаниколау зерттеу әдісі, бауырға (гемигепатэктомия және біріктірілген бірнеше дене мүшелеріне) оташылдық ем жасау, құралас сәуле емі (жатыр мойнына, өңешке, несеп жолдарына жаңа технологиямен емдеу) әдістері іске асты. Цифрлы маммография әдісі енгізіліп, маммографиялық қор жасауға мүмкіндік туды.

Өкінішке орай, онкологиялық ауруларды асқынған IY сатысында жалпы емдеу мекемелері симптоматикалық ем жасауға алмайды, сол себепті де онкологиялық төсек орынды көбейту, немесе хоспис ашу бүгінгі күннің өзекті мәселесі.

Қорыта айтқанда, облыс көлемінде қатерлі ісіктермен белсенді күресуге жағдай жасалған. Оны жақсартуға маманданған онкология саласымен алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін мекемелерінің өзара тығыз байланысы мүмкіндік береді.

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Толеутай У.К.

Высшая школа общественного здравоохранения

Рак молочной железы у женщин является одной из наиболее распространенных форм злокачественных новообразований. В структуре онкологической заболеваемости женского населения в Кызылординской области до 2008 года он занимал 2-е место, следуя после рака пищевода. Однако высокий темп прироста заболеваемости и смертности от рака молочной железы, опережающий большинство других опухолей, выдвигает эту проблему на ведущее место в противораковой борьбе.

Целью исследования было изучение этнических особенностей заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) жительниц Приаралья.

Материалы и методы исследования. Исследование охватывает 10 лет (2000-2009). Источниками исследования были учетно-отчетные документы Кызылординского областного онкологического центра, где взяты на «Д» учет больные с впервые в жизни установленным диагнозом РМЖ. Вычислены экстенсивные, грубые, стандартизованные и возрастные показатели заболеваемости РМЖ по общепринятым методом санитарной статистики.

В структуре онкологической заболеваемости населения за 2009 год РМЖ занимает 4-е место. С 2009 года в структуре онкологической заболеваемости среди женского населения Кызылординской области РМЖ занимает 1-е место.

В структуре населения Кызылординской области по данным переписи населения 2009г. преобладают лица казахской национальности и составляют 95,8%; русской - 1,9%; корейской - 1,2%; других национальностей - 1,1%.

За 10 лет (2000-2009) в области было зарегистрировано 626 – женщин с РМЖ, из них 515 (82,2%) женщин казахской национальности, 69 (11%) – русских и 24 (3,8%) – корейок, 16 (2,8%) – женщины других национальностей. Основную группу больных (98,8%) составили женщины казахской, русской и корейской национальностей.

Принимая сумму показателей заболеваемости за десятилетний период за 100% (в абсолютных числах - 626), опреде-

лен удельный вес каждой национальности раком молочной железы. Основную группу больных из 626 женщин с раком молочной железы составили женщины казахской, русской и корейской национальностей (608-97,13%). При оценке процентного распределения абсолютного числа впервые выявленных больных РМЖ за 10 летний период наиболее высокую долю составили казашки, а при вычислении частоты заболеваемости на 100 000 населения каждой национальности, также за последний 10-летний период, высокий интенсивный показатель наблюдался среди русской (50,2), корейской (29,5) и других (24,2) национальностей, тогда как среди казашек грубый показатель (8,8) отмечался на низком уровне.

За 10-летний период РМЖ у казашек увеличился в 1,7 раз, у русских в 2,2 раза и корейок в 2,8 раз. Динамика роста заболеваемости РМЖ у казашек носит постепенный, а у русских и корейок волнообразный характер.

Таким образом, анализ заболеваемости РМЖ показал, что во всех этнических группах отмечается тенденция к росту. Следует обратить внимание об особенностях распространения рака молочной железы в Кызылординской области, что в дальнейшем должно лечь в основу планируемых мероприятий на местах.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ

Ерубаев С.Ж.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: меланома – это чрезвычайно злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов - пигментных клеток, продуцирующих специфический полипептид меланин. Характерным для меланомы является скопление меланина в клетках опухоли, хотя встречаются так называемые беспигментные меланомы. Ежегодно на учёт в Павлодарской области берётся до 30 человек. В структуре первичной заболеваемости меланома кожи составляет 0,5%.

Цель работы: проанализировать динамику эпидемиологических показателей меланомы кожи за 2000 – 2004 годы в Павлодарской области.

Материалы и методы: истории болезни, амбулаторные карты пациентов, взятых на учёт в 2000 – 2004 годах, статистические отчёты.

Основные показатели по меланоме кожи за 2000 – 2004 годы

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004
Взято на учёт	22	20	26	17	28
В т.ч.					
Мужчины	10	7	11	5	14
Женщины	12	13	15	12	14
Город	22	20	26	10	28
Село				7	
По стадиям:					
I-II	20	18	21	12	22
III			5	4	4
IV	2	2		1	2
Заболеваемость на 100000 нас.	2,8	2,6	3,4	2,3	3,7
Умерло	3	8	5	11	8
Смертность на 100000 нас.	0,4	1,0	0,7	1,5	1,1
Ранняя диагностика	90,9%	90%	80,8%	70,6%	78,6%
Запущенность (IV)	9,1%	10%	0	5,9%	7,1%
Запущенность с учётом III стадии	9,1%	10%	19,2%	29,4%	21,4%
Одногодичная летальность	15%	13,6%	10%	0	11,5%
Состоит на учёте	109	129	148	149	168

Пятилетняя выживаемость	55%	53,5%	47,9%	51,7%	53,6%
----------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

Результаты и выводы. Меланома чаще встречается у лиц женского пола и у жителей города.

Заболеваемость за 5 лет повысилась на 32%. Среднегодовой прирост 8%.

Ранняя диагностика понизилась за счёт роста удельного веса заболевания, выявленного в III стадии.

Запущенность (IV ст.) понизилась за 5 лет на 2%.

Пятилетняя выживаемость чуть выше 50%, что свидетельствует о чрезвычайной злокачественности меланомы.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В 2009г. В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мукушева А.Х.

КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар

Актуальность: рак шейки матки прочно занимает 2 место в структуре онкозаболеваемости женского населения области. За последние 5 лет наметилась тенденция к увеличению заболеваемости раком шейки матки, которая в 2009г. составила 9,3 на 100 тыс.нас. Смертность от рака шейки матки за последнее 5-летие существенно не изменилась и составила в 2009г. 5,3 на 100000 нас. при Республиканском показателе 4,4. Показатель ранней диагностики увеличился по сравнению с 2005г. на 15,3% и составил 62,9%. Показатель поздней диагностики за 2009г. понизился по сравнению с 2008г. на 3,2%. С учётом III стадии показатель понизился с 41,9 % в 2005г. до 37,1% в 2009г. Проведение цитологического скрининга с целью раннего выявления рака шейки матки в ранних стадиях его развития является единственным шансом улучшить онкологическую ситуацию по этой нозологии.

Материалы и методы: годовые статистические отчёты, отчёты цитологической лаборатории за 2009 год.

Цель работы: проанализировать эффективность проводимого в области профилактического осмотра в целях раннего выявления рака шейки матки путём цитологического скрининга.

В 2009г. цитологический скрининг в Павлодарской области проведён 21175 женщинам в возрасте 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет и 86533 женщинам других возрастов. Обследовано 101019 женщин с профилактической целью и 6689 с диагностической целью. Всего выявлено 29867 случаев патологии, что составляет 27,7% от общего количества обследованных. 3 случая рака шейки матки выявлены при профилактическом цитологическом скрининге в рамках Республиканской программы по ранней диагностике рака шейки матки, 11 – у женщин других возрастов. Кроме того, выявлено дисплазий лёгкой степени 4799, средней степени – 769, тяжёлой степени – 104, эрозий шейки матки – 632, инфекций, передающихся половым путём – 760, воспалительных заболеваний шейки матки – 22789. При анализе запущенных случаев рака шейки матки выявлено, что 64% запущенных случаев регистрируются в возрастной группе женщин старше 50 лет. Цитологическое исследование цервикальных мазков по Папаниколау остается основным методом скрининга заболеваний шейки матки. Метод дает возможность оценить структуру и клеточный уровень повреждения тканей, попавших в мазок-отпечаток. Основной целью цитологического исследования является выявление морфологических особенностей клеток, характеризующих конкретный процесс. Учитываются клеточные, структурные и

функциональные признаки злокачественного перерождения клеток. Ложноотрицательные ответы гораздо чаще связаны не с погрешностями работы цитоморфолога, а с нарушениями техники сбора и обработки цитологического материала. При этом выявилась зависимость качества мазков от характера используемых инструментов. Мы добиваемся, чтобы техника забора Пап – мазков была строго регламентирована. Лучшим методом сбора клеток признано использование комбинации шпателя Эйра и эндоцервикальной щетки. Такая комбинация может способствовать более эффективному выявлению атипичного эпителия.

Результаты и выводы: в связи с высоким уровнем заболеваемости раком шейки матки цитологический метод занимает главенствующую роль в ранней диагностике, позволяя повысить выявляемость рака шейки матки на ранних стадиях, увеличить число больных с 5-летней выживаемостью до 90% и снизить смертность от этого заболевания. Необходимо более активно проводить цитологический скрининг женщинам в возрасте старше 50 лет.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЖЕЛУДКА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В 2003-2007 ГГ.

Ассесорова Ю.Ю., Киреев Г.В.

Несмотря на снижение частоты заболеваемости раком желудка (РЖ), имеющее место в последние десятилетия, эта патология продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО). В Республике Узбекистан доля РЖ в структуре заболеваемости ЗНО составляет 9,6%, а в структуре заболеваемости ЗНО органов пищеварения – 35,5%.

Анализ первичных данных за период 2003-2007 гг. позволил установить, что средний многолетний уровень заболеваемости РЖ в Республике Узбекистан составил $6,7 \pm 0,07$ на 100 тыс. населения. Среди административно-территориальных единиц Республики Узбекистан самый высокий уровень заболеваемости РЖ ежегодно регистрируется в г.Ташкенте: среднее пятилетнее значение составило $12,1 \pm 0,89$ на 100 тыс. населения, что в 1,8 раза превышает данный показатель по Республике в целом. Высокий уровень заболеваемости РЖ отмечается также в Андижанской области ($9,7 \pm 0,41$ на 100 000 населения), Республике Каракалпакстан ($8,4 \pm 0,39$) и Ташкентской области ($8,1 \pm 0,27$). Самые низкие уровни заболеваемости данной формой онкопатологии зарегистрированы в Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской и Джизакской областях (соответственно, $4,2 \pm 0,26$; $4,5 \pm 0,29$; $4,9 \pm 0,15$; $4,9 \pm 0,27$ на 100 тыс. населения).

Изучение динамики заболеваемости РЖ в отдельных регионах Узбекистана за период 2003-2007 гг. показало, что в Наманганской, Самаркандской, Навоийской, Андижанской и Ташкентской областях, а также в Республике Каракалпакстан имела место тенденция к снижению заболеваемости данной формой онкопатологии. В Ферганской и Сырдарьинской областях заболеваемость РЖ возросла в 1,2 раза, в Кашкадарьинской и Бухарской областях – в 1,3 раза, в Джизакской области – в 1,7 раза.

Средний многолетний уровень заболеваемости РЖ среди мужского населения в целом по РУз составляет $8,6 \pm 0,10$ на 100 тыс. населения, что в 1,8 раза выше заболеваемости среди женского населения ($4,8 \pm 0,06$). В отдельных регионах количество мужчин с впервые установленным диагнозом РЖ еще более значительно. Так, в Джизакской и Хорезмской областях соотношение заболевших женщин и мужчин составляло 1:2; в Навоийской, Ташкентской областях и Республике Каракалпакстан – 1:2,1; в Сырдарьинской области – 1:2,2.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЯИЧНИКОВ ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

Югай Т.А.

Городской онкологический диспансер, г. Алматы

Проблема диагностики и лечения злокачественных новообразований яичников является одной из наиболее актуальных в современной онкологии. Ежегодно в мире регистрируются 165000 больных раком яичников и 101000 из них погибают от прогрессирования заболевания. Проведенный анализ заболеваемости раком яичников за три года по г. Алматы показал, что уровень заболеваемости остается относительно стабильным. Однако за последнее десятилетие отмечено некоторое снижение заболеваемости раком яичников. По городу Алматы показатель заболеваемости в 2008 году составил 6,5 на 100 тыс. женского населения (6,7 на 100 тыс. женского населения в 2007 году). Учитывая клинические особенности течения рака яичников, даже такая динамика снижения заболеваемости не улучшает онкоситуацию в целом.

Проблема своевременной диагностики рака яичников является весьма актуальной. До настоящего времени у 75% больных раком яичников заболевание выявляется на поздних стадиях с 5-летней выживаемостью не более 15-20%. Большинство больных поступают в онкологические учреждения с запущенными стадиями опухолевого процесса яичников – в среднем 46,5% больных со злокачественными опухолями яичников с III стадией и 21% больных с IV стадией заболевания. Причины позднего выявления опухолей были обусловлены как бессимптомным течением заболевания на ранних стадиях, так и врачебными ошибками в диагностики из-за недостаточного знания семиотики злокачественных опухолей, длительного наблюдения за больными без уточненного диагноза, недостаточного использования всего возможного арсенала диагностических методов.

Грозным признаком недостаточной онконастороженности врачей общей лечебной сети являются участвовавшие случаи поступления в отделение онкогинекологии женщин с нерадикальным объемом операции их в ЛПУ города. Как правило, прогноз течения заболевания этих пациенток неблагоприятен, ввиду обширного интраоперационного обсеменения рака. Участились случаи нерадикальных операций, проводимых лапароскопическим методом, хотя малейшее подозрение на рак яичников является абсолютным противопоказанием к лапароскопической хирургии.

Учитывая объективные трудности дифференцированной диагностики рака яичников (отсутствие патогномоничных признаков), при появлении жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, наличие асцита, болей в животе неопределенного характера, пальпируемых образований в брюшной полости, необходимо исключить рак яичников.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Ажмагамбетова А.Е., Оспанов М.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Северный регион РК включает три области: Акмолинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую области.

Изучены особенности распространения рака легкого в северном регионе за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в этих областях 7924 больных раком легкого (РЛ).

Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели заболеваемости.

В Акмолинской области в первый временной период (2000-

2002 гг) заболеваемость РЛ по среднегодовым ИП снизилась незначительно с 43,8 до 41,0‰. Отмечается соответственно снижение по СП - с 30,1 до 28,6‰. Заболеваемость РЛ среди мужского населения со значительным снижением с 76,4 ‰ до 72,5‰ (СП 63,8-60,4‰). РЛ женского населения стабилен: ИП 13,2‰, СП - 8,2‰. Среднегодовые ИП по РЛ во второй период в динамике показали дальнейшее снижение заболеваемости с 41,0 до 39,1‰ в 2005 году и СП от 27,9 до 26,3‰. Во второй период среди мужского населения заболеваемость РЛ продолжает снижаться до 66,7‰, СП – до 55,2‰. У женского населения показатели РЛ с незначительным ростом на 0,2‰ при стабильном СП (8,2‰). В третий временной период заболеваемость РЛ имеет тенденцию к снижению с 37,2 до 35,4‰, СП с 25,6 до 24,1‰. Среди мужского населения тенденция снижения сохраняется: ИП 64,8-60,9‰, среди женщин – незначительный рост до 13,6‰, СП - 8,0‰.

В Костанайской области в 2000-2002 г. заболеваемость РЛ находится на одном уровне: 34,5-34,2‰. Среди мужского населения РЛ стабилен: 59,9‰, у женщин – ИП снизились от 11,3 до 10,5‰. Среднегодовые ИП по РЛ за 2003-2005 г. составили 33,8-33,3‰. Среди мужского населения заболеваемость на одном уровне 59,8‰, среди женского – незначительное снижение ИП 10,3-9,4‰. Среднегодовые показатели по РЛ в третий период с постепенным снижением с 33,0 до 32,6‰. Среди мужского населения ИП на 0,1‰ ниже, среди женского – на 0,8‰ к 2008 году.

В Северо-Казахстанской области в 2000-2002 гг отмечается тенденция снижения заболеваемости РЛ всего населения с 42,3 до 40,9‰, среди мужского населения: с 75,1 до 73,0‰, среди женского – с 11,7 до 11,1‰. В 2003-2005 гг дальнейшее снижение заболеваемости РЛ с 40,2 до 38,8‰, среди мужчин ИП снизились с 71,9 до 69,8, среди женщин – с 10,8 до 10,2‰. Среднегодовые ИП по РЛ в третий период были в пределах 38,1-36,8‰, среди мужского населения отмечается медленный спад заболеваемости с 68,7 до 66,6‰, среди женщин – с 9,9 до 9,2‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком легкого по северному региону Республики показал при ранжировании большую распространенность РЛ в Северо-Казахстанской области, затем в Акмолинской и Костанайской областях.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В ВОСТОЧНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Ажмагамбетова А.Е.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Восточный регион РК включает две большие области: Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую. Центральный регион представлен Карагандинской областью. Изучены особенности распространения рака легкого (РЛ) в них за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в этих областях 11211 больных РЛ. Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели.

В Восточно-Казахстанской области в первый временной период (2000-2002 гг) заболеваемость РЛ по интенсивным показателям была с небольшим спадом от 41,8 до 40,7‰. Заболеваемость РЛ среди мужского населения области высокая и в 2000 году составила 71,9‰, но постепенно снизилась до 70,5‰. Соответственно СП были 73,2-72,9‰. Заболеваемость РЛ среди женского населения была почти в 5 раз ниже, чем среди мужского. ИП в 2000 году была 14,4‰, к 2002 году она стала 13,5‰.

ИП по РЛ среди всего населения во второй период продолжают снижаться со 40,1‰ до 39,0‰. У мужчин эти показатели соответственно 69,9-68,5‰, среди женского населения – 13,1-12,2‰. В 2006 году ИП в области по

РЛ составили 38,4‰ с постепенным понижением до 37,3‰. Среди мужского и женского населения тенденция сохраняется: у мужчин – 67,9‰, у женщин – 11,7‰. В 2008 году соответственно 60,6 и 10,9‰.

В Павлодарской области в 2000-2002 гг заболеваемость РЛ составила 32,4‰, но имеется рост в течение указанного периода до 33,4‰ у всего населения области. Среди мужчин отмечается рост ИП – с 55,8 до 58,0‰, среди женщин отмечается стабильный ИП 11,2‰. Заболеваемость во второй временной период имеет тенденцию к небольшому росту до 34,9‰, среди мужчин – с 59,1 до 61,2‰, среди женщин – небольшой рост ИП до 11,4‰. В третий временной период заболеваемость всего населения постепенно растет с 35,4 до 36,5‰. У мужчин эти показатели – 62,3 – 64,4‰, среди женского населения отмечается стабилизация заболеваемости с ИП 11,5‰.

В Карагандинской области в 2000-2002 гг заболеваемость РЛ с 33,7 снизилась до 32,3‰. Среди мужского населения отмечается также спад ИП с 58,1 до 55,6‰, и медленное снижение заболеваемости у женского населения – с 11,8 до 11,3‰. В 2003-2005 гг отмечается снижение заболеваемости РЛ в целом по области с 31,5‰ до 30,0‰. Среди мужского населения – с 54,3 до 51,7‰, у женщин – с 11,1 до 10,7‰. В третий временной период заболеваемость РЛ продолжает уменьшаться в 2006 году с 29,3‰ до 27,8‰ в 2008 году. ИП заболеваемости РЛ у мужчин составили 50,4‰, и в конце периода – 47,8‰. Заболеваемость по РЛ среди женского населения с медленным темпом снижения с 10,5 до 10,1‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком легкого по восточному и центральному региону Республики при ранжировании показал большую распространенность РЛ в Восточно-Казахстанской, затем в Павлодарской и Карагандинской областях.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Жапарова Д.Д.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Южный регион РК включает четыре области: Южно-Казахстанскую (ЮКО), Кызылординскую (КЗО), Жамбылскую и Алматинскую. Изучены особенности распространения рака легкого (РЛ) в южном регионе за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в регионе 6940 больных РЛ. Методами санитарной статистики рассчитаны показатели заболеваемости.

В Южно-Казахстанской области в первый временной период (2000-2002 гг) заболеваемость РЛ была в пределах 12,4-11,5‰. Среди мужского населения отмечается тенденция снижения: ИП с 18,4 до 16,8‰, у женщин – спад заболеваемости значительно медленнее: 6,0-5,6‰. Во второй период заболеваемость в области РЛ снизилась с 11,0 до 10,1‰ в 2005 г, среди мужчин – с 16,0 до 14,4‰, и значительно меньше среди женского населения: 6,4-5,0‰. В 2006-08 гг заболеваемость РЛ продолжает снижаться с 9,6 до 8,6‰, среди мужского населения с 13,6 до 12,1‰, среди женщин – с 4,7 до 4,3‰.

В Кызылординской области в 2000-2002 гг заболеваемость РЛ была с постепенным снижением с 21,2 до 20,6‰. Среди мужского населения отмечается спад с 30,9 до 30,1‰, среди женщин – с 10,9 до 10,6‰. Во второй временной период в динамике имеется снижение заболеваемости в области с 20,3 до 19,7‰, у мужчин – с 29,7 до 28,9‰, у женщин с 10,9-10,6‰. Заболеваемость РЛ в 2006-2008 гг продолжает снижаться с 19,4 до 18,8‰, среди мужского населения – с 28,5 до 20,6‰, среди женского – с 10,4 до 10,0‰.

В Жамбылской области в 2000-2002 гг отмечается тенденция к значительному спаду заболеваемости РЛ всего населения – с 17,2 до 16,6‰, и среди мужчин: с 28,6 до 27,4‰. У женщин показатели РЛ стабильны 6,5‰. В 2003-2005 гг продолжается спад заболеваемости с 16,2 до 15,5‰, среди мужского населения с 26,8 до 25,6‰, у женщин показатели с незначительным изменением: 6,3‰. В третий период заболеваемость РЛ продолжает снижаться с 15,2 до 14,5‰. Более значительный спад показателей среди мужского населения с 25,0 до 23,8‰, и слабое понижение с 6,3 до 6,2‰ у женщин.

В Алматинской области заболеваемость РЛ постепенно снижается с 18,3 до 17,3‰ за 2000-2002 гг. Среди мужского населения заболеваемость снизилась с 30,9 до 29,1‰, среди женского с 6,3 до 6,0‰. Во второй временной период темп постепенного снижения продолжается с 16,8 до 15,9‰, у мужчин с 28,3 до 26,6‰, у женщин с 5,9 до 5,6‰. Заболеваемость РЛ в третий временной период тенденция снижения сохраняется, составив 15,4 в 2006 году, дойдя до 14,4‰ в 2008 году. Среди мужчин показатели понизились с 25,4 до 24,0‰, у женского населения – незначительное снижение: с 5,4 до 5,2‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком легкого по южному региону республики при ранжировании показал большую распространенность РЛ в Кызылординской, в Алматинской, затем в Жамбылской, Южно-Казахстанской областях.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Жапарова Д.Д., Аймагамбетова А.Е., Петухов А.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Западный регион включает четыре области: Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Мангистаускую.

Изучены особенности распространения рака легкого в западном регионе Республики Казахстан за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в регионе 4422 больных раком легкого (РЛ).

Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели.

В Актюбинской области в первые три изучаемых года (2000-2002 гг.) заболеваемость РЛ относительно на одном уровне с небольшим снижением 24,6-23,8‰, СП – 21,2-20,5‰. Среди мужского населения тенденция снижения сохраняется с ИП – 42,2-40,7‰, СП – 43,7-42,5‰, у женщин незначительное снижение заболеваемости: ИП – 8,2-8,0‰, СП – 6,3-6,1‰. В 2003-2005 гг. ИП по РЛ в динамике продолжается постепенное снижение до 22,5‰, СП – до 19,4‰. Среди мужского населения ИП снизились с 40,0 до 38,5‰, при СП – 41,9-41,8‰. У женщин заболеваемость по ИП – 7,8-7,6‰, СП – 6,0-5,7‰. В третьем периоде заболеваемость РЛ снижается до 21,2‰, у мужчин – до 38,5‰ (ИП), СП – до 40,8‰. Среди женского населения ИП были 7,4-7,2‰, СП – 5,6-5,4‰.

В Западно-Казахстанской области в начальном периоде наблюдается относительный уровень стабильности заболеваемости 33,9-33,3‰. Среди мужского населения показатели в пределах 62,2-59,3‰. У женского населения отмечается небольшой рост заболеваемости – 7,4-7,7‰. В 2003-2005 гг. заболеваемость постепенно снижается с 32,1 до 30,8‰, среди мужчин – с 57,9 до 56,0‰. У женщин заболеваемость выросла с 7,9 до 8,3‰. В третьем периоде тенденция снижения продолжается у всего населения – с 30,2 до 29,0‰, также и среди мужчин – 53,5 до 50,6‰. Среди женщин отмечается небольшой рост с 8,5 до 8,8‰.

В Атырауской области заболеваемость РЛ за 2000-2002 гг

медленно снизилась с 20,5 до 20,2‰. Среди мужского населения тенденция снижения сохраняется: ИП 35,7-35,0‰, СП 44,9-44,3‰; заболеваемость РЛ у женщин с медленным ростом ИП 6,0-6,1‰, СП 5,1-5,2‰. Во втором периоде намечается постепенное снижение заболеваемости с 20,1 до 19,8‰, среди мужского населения: ИП снизились с 34,6 до 33,8‰, СП – с 44,1 до 43,5‰. У женского населения тенденция роста сохраняется: ИП 6,2-6,3‰, СП 5,3-5,4‰. В третий период ИП по РЛ относительно стабильны 19,6-19,3‰. Несколько выражен спад среди мужского населения: ИП 33,4-32,6‰, СП 43,2-42,7‰. У женщин наблюдается медленное повышение заболеваемости: ИП 6,4-6,5‰, СП 5,6-5,7‰.

В Мангыстауской области в первый период заболеваемость РЛ была в пределах 16,3-15,4‰. Среди мужского населения наблюдается снижение показателей с 25,0 до 23,1‰, среди женщин показатели стабильны: 5,0‰. В следующие годы наметилась тенденция постепенного снижения заболеваемости с 14,9 до 14,0‰. В 2006-2008 гг. снижение уровня заболеваемости РЛ продолжается с 13,5 до 12,6‰. Среди мужчин снижение с 22,2 до 20,3‰ при стабильных показателях у женского населения 5,0‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком легкого по западному региону республики при ранжировании показал большую распространенность РЛ в Западно-Казахстанской, затем в Актыбинской, Атырауской и Мангыстауской областях.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

*Игисинов С.И., Сейсенбаева Г.Т.,
Имангалиева Н.Т., Петухов А.В.*

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Западный регион включает четыре области: Актыбинскую, Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Мангыстаускую.

Изучены особенности распространения рака шейки (РШМ) и тела матки в западном регионе Республики Казахстан за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в регионе 1345 больных РШМ и 769 больных раком тела матки (РТМ).

Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели.

В Актыбинской области в первые три изучаемых года (2000-2002 гг.) заболеваемость РШМ относительно на одном уровне, в среднем составив 12,8‰. Заболеваемость по интенсивным показателям РТМ снизилась с 9,2 до 7,0‰, по СП – с 8,6 до 7,0‰.

В 2003-2005 гг. ИП по РШМ составил 15,1‰, в динамике намечается тенденция роста с 13,3 до 16,7‰, а также и по РТМ – с 6,4 до 7,9‰ при СП 6,2-7,8‰.

Среднегодовой ИП по РШМ за 2006-2008 гг. на прежнем уровне 15,3‰. Заболеваемость была понижена в начальном периоде – 13,7‰, затем отмечен рост до 16,1‰. ИП по РТМ снижается с 9,5 до 8,5‰ при более стабильных стандартизованных показателях 8,9-8,2‰.

В Западно-Казахстанской области в 2000-2002 гг. наблюдается в динамике тенденция роста РШМ с 9,9 до 12,2‰. Заболеваемость РТМ составила в среднем 11,3‰, при снижении СП с 10,9 до 9,8‰. В 2003-2005 гг. уровень заболеваемости РШМ сохраняется в пределах с 12,8 до 12,1‰, а РТМ в пределах 11,3 и 11,2‰ при снижении СП с 10,9 до 9,8‰. Среднегодовой ИП по РШМ за 2006-2008 гг. составил 14,9‰ и при этом вырос на 2,2‰ по сравнению с прошлым периодом. В целом по заболеваемости РТМ в этот период в области отмечается постепенное снижение с 13,6 до 10,0‰, при соответствующем СП – 11,5-7,9‰.

В Атырауской области заболеваемость РШМ за 2000-2002 г. составила 13,2 - 13,5‰ и по РТМ – 3,5-6,9‰.

Среднегодовой ИП заболеваемости РШМ в 2003-2005 гг. вырос до 20,4‰, показатели по РТМ в это период выросли с 6,9 до 8,4‰ с более высокими СП 7,6-9,5‰. В третий период ИП по РШМ выросли с 16 до 20,1‰. Заболеваемость по РТМ снижается с 7,4 до 4,7‰, соответственно СП – 7,9-5,6‰.

В Мангыстауской области в первый период заболеваемость РШМ была 6,9‰, отмечалась тенденция спада с 9,9 до 4,2‰. ИП по РТМ выросли с 6,8 до 7,7‰ при достаточно высоких СП 9,9-9,5‰. В следующие годы среднегодовой ИП по РШМ составил 9,9‰, при этом показатель вырос на 3‰ по сравнению с предыдущим периодом. Заболеваемость по РТМ стала снижаться с 8,1 до 6,5‰ при более стабильных СП 8,6-8,2‰. Среднегодовой ИП по РШМ в 2006-2008 гг. составил 9,1‰. Заболеваемость РТМ в области в последние годы была в пределах 5,7-4,7‰ при более высоких и стабильных СП 6,5-5,9‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком шейки и тела матки по западному региону республики при ранжировании показал большую распространенность РШМ в Атырауской, затем в Актыбинской, Западно-Казахстанской и Мангыстауской областях.

Заболеваемость по РТМ была первой по рангу в Западно-Казахстанской, затем в Актыбинской, Атырауской и Мангыстауской областях.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Игисинов С.И., Имангалиева Н.Т., Петухов А.В., Садык М.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Южный регион РК включает четыре области: Южно-Казахстанскую (ЮКО), Кызылординскую (КЗО), Жамбылскую и Алматинскую. Изучены особенности распространения рака шейки (РШМ) и тела матки в южном регионе за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в регионе 1779 больных РШМ и 668 раком тела матки (РТМ). Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели.

В Южно-Казахстанской области в первый временной период (2000-2002 гг.) заболеваемость РШМ по среднегодовым интенсивным показателям снижалась с 8,8 до 6,8‰. ИП заболеваемости по РТМ на одном уровне: 3,0-3,2‰, но с постепенным ростом СП – с 3,2 до 4,3‰. Среднегодовые ИП по РШМ во второй период составили 10,1‰, в динамике – рост с 10,5 до 11‰ в 2005 г. По РТМ заболеваемость в области была с постепенным ростом в первые два года, составив 4,0-3,6‰. Однако в 2005 году наблюдается резкий спад до 2,0‰ соответственные показатели по СП – 5-4,7 и 2,4‰. В 2006-08 гг. заболеваемость РШМ имеет тенденцию к росту с 8,2 до 11,1‰. Показатель заболеваемости по РТМ высокий в 2006 году – 4,7‰, к 2008 году снизился до 3,6‰. Одновременно эта тенденция отмечена у СП: 6,1-4,5‰.

В Кызылординской области в 2000-2002 гг. заболеваемость РШМ составила 8,8‰, но имеется рост в течение указанного периода с 5,6 до 8,3‰. Заболеваемость по РТМ в пределах 3,6-4,0‰ при достаточно высоких СП – 4,6-5,2‰. Среднегодовой ИП по РШМ за 2003-2005 гг. составил 10,4‰. Однако необходимо отметить, что в динамике имеется спад заболеваемости в области с 10,5 до 6,8‰ в 2003-2005 гг., что немного ниже данных предыдущего периода. ИП заболеваемости по РТМ постепенно снижается с 4,3 до 3,9‰, соответственно СП – с 5,1 до 4,4‰. Среднегодовой показатель по РШМ за 2006-2008 гг. составил 12‰. По сравнению с предыдущим периодом ИП увеличился на 1,6‰. Заболеваемость по РТМ снизилась с 4,2 до 2,8‰, СП – с 5,0 до 3,3‰.

В Жамбылской области в 2000-2002 гг. отмечается тенден-

ция к значительному спаду заболеваемости РШМ – с 14,9 до 9,9‰ со среднегодовым ИП 11,8‰. ИП заболеваемости по РТМ были высокими в первые годы периода – 5,8-8,5‰. Однако в 2002 году спад заболеваемости до 2,6‰. При этом СП в пределах 6,2 и 2,7‰. В 2003-2005 гг характерна тенденция роста РШМ с 9,1 до 12,7‰. Заболеваемость по РТМ постепенно выросла с 3,8 до 5,1‰, соответственно СП с 3,9 до 5,4‰. В третий период ИП по РШМ в среднем 12,7‰ при стабильных годовых показателях последние два года – 13,2-13,4‰. Заболеваемость по РТМ высокая в 2006-2007 гг, составившая 6,2‰ с небольшим снижением в 2008 году – 4,7‰. СП на таком же уровне, как и ИП.

В Алматинской области заболеваемость РШМ колеблется с 13,6 до 15,8‰ за 2000-2002 гг. Заболеваемость по РТМ снижается с 5,8 до 3,3‰, соответственно СП остается на том же уровне – 6,1-3,3‰. Среднегодовой ИП по РШМ за 2003-2005 гг составляет 15,5‰, имея тенденцию к небольшому спаду. По РТМ заболеваемость растет с 4,5 до 6‰, одновременно с СП с 4,2 до 6,0‰. Заболеваемость РШМ за 2006-2008 г. имеет тенденцию снижения с 20,5 до 16,2‰. Она сохраняется по РТМ, составив ИП 7,8-5,4‰, и соответственно СП – 7,4-5,2‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком шейки и тела матки по южному региону республики при ранжировании показал большую распространенность РШМ в Алматинской области, затем в Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях. Заболеваемость по РТМ была первой по рангу в Алматинской, затем в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В ВОСТОЧНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

*Сейтказина Г.Д., Чингисова Ж.К.,
Сейсенбаева Г.Т., Ажмагамбетова А.Е.*

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Восточный регион РК включает две большие области: Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую. Центральный регион представлен Карагандинской областью. Изучены особенности распространения рака шейки (РШМ) и тела матки в них за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в этих областях 4562 больных РШМ и 2616 раком тела матки (РТМ). Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели.

В Восточно-Казахстанской области в первый временной период (2000-2002 гг) заболеваемость РШМ по интенсивным показателям выросла с 12,8 до 18,5‰, в среднем составив 15,3‰. ИП заболеваемости по РТМ вырос с 12,3 до 14,1‰. Заболеваемость по РТМ была с темпом снижения с 13,1 до 10,9‰ при СП 10,3-8,8‰. Среднегодовые ИП по РШМ во второй период составили 17,1‰, со стабильными показателями все три года. По РТМ заболеваемость в области только в 2004 году выросла до 15,3‰, в начале и конце временного периода оставалась на одном уровне – 14,3‰. Однако СП продолжали постепенно расти с 8,8 до 11,5‰. В 2006-08 гг заболеваемость РШМ с тенденцией снижения с 20,3 до 17,0‰, со средними данными 18,9‰. В 2006 году ИП по РТМ были низкими – 10,7‰, затем отмечается рост до 14,9‰. Соответственно СП выросли с 7,3 до 11,0‰.

В Павлодарской области в 2000-2002 гг заболеваемость РШМ составила 16,3‰, но имеется рост в течение указанного периода с 14,6 до 17,9‰. ИП по РТМ относительно стабилен в пределах 16,8-16,9‰, но с постепенным снижением СП с 14,5 до 13,9‰. Среднегодовой ИП по РШМ за 2003-2005 г. составил 14,6‰. Необходимо отметить, что

постепенный рост показателей отмечался в течение трех лет с 13,7 до 15,6‰. Заболеваемость по РТМ в этот период снижается с 19,3 до 16,1‰. Следует отметить эту тенденцию по СП – с 16,0 до 12,6‰. Среднегодовой показатель по РШМ за 2006-2008 г. составил 19,5‰. Весь период исследования данные были на одном уровне (19,3-19,7‰). Заболеваемость по РТМ по данным ИП в области высокая в 2006 году – 19,6‰ со снижением до 17,2‰. Такие же показатели СП – 15,0-15,2‰.

В Карагандинской области в 2000-2002 гг отмечается тенденция роста заболеваемости РШМ – с 13,2 до 17,8‰ со среднегодовым ИП 14,9‰. По РТМ отмечается постепенный рост заболеваемости с 17,5 до 19,7‰. Однако СП на одном уровне – 15,2-15,7‰. В 2003-2005 гг отмечается рост заболеваемости РШМ с 17,1‰ до 18,2‰ со средними показателями 17,6‰. Заболеваемость по РТМ в этот период на одном уровне: 15,8 - 16,8‰ при постепенном снижении СП с 13,6-до 10,6‰. В третий временной период заболеваемость РШМ несколько повысилась в 2007 году до 17,3‰. Средние показатели составили 16,9‰. Заболеваемость по РТМ с медленным темпом роста 15,8-16,8‰ и соответствующим СП – 12,2 – 12,7‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком шейки и тела матки по восточному и центральному региону Республики при ранжировании показал большую распространенность РШМ в Павлодарской области, затем Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Заболеваемость по РТМ была первой по рангу в Павлодарской, затем в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

*Сейтказина Г.Д., Оспанов М.А.,
Чингисова Ж.К., Сейсенбаева Г.Т.*

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Северный регион РК включает три области: Акмолинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую области.

Изучены особенности распространения рака шейки (РШМ) и тела матки (РТМ) в северном регионе за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в этих областях 1863 больных РШМ и 1583 раком тела матки.

Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели заболеваемости.

В Акмолинской области в первый временной период (2000-2002 гг) заболеваемость РШМ по среднегодовым интенсивным показателям снизилась с 18,6 до 15,2‰, а также ИП заболеваемости по РТМ стали ниже с 17,2 до 13,1‰, стандартизованные показатели составили 14,8-11,0‰. Среднегодовые ИП по РШМ во второй период составили 19,3‰, в динамике наблюдается рост показателей с 15,8 до 24,0‰ в 2005 году. По заболеваемости РТМ в области интенсивные показатели выросли с 11,1 до 16,0‰ и по СП – с 8,3-18,3‰. Заболеваемость РШМ имеет тенденцию к снижению с 19,1 до 16,3‰ в 2006-08 гг, со средними данными ИП 17,4‰, по РТМ они выросли до 11,7‰, и его СП составил 9,4‰.

В Костанайской области в 2000-2002 г. заболеваемость РШМ составила 15,6‰, но имеется рост в течение указанного периода с 14,8 до 17,3‰. Показатели ИП по РТМ в этот период снизились с 14,0 до 12,5‰, по СП – с 11,5 до 9,1‰. Среднегодовой ИП по РШМ за 2003-2005 г. составил 18,3‰. Однако необходимо отметить, что динамика волнообразна, и заболеваемость в 2004 году была низкой 15,5‰, в 2005 году вновь отмечается рост до 19,7‰, как и в 2003 году. ИП заболеваемости по РТМ также с тен-

денцией роста с 14 до 15,6‰, при этом СП -10,3‰ – 11,0‰. Среднегодовой показатель по РШМ за 2006-2008 г. составил 19,7‰. По сравнению с предыдущим периодом ИП увеличился на 1,4‰. Для динамики ИП характерен постепенный рост заболеваемости РТМ в области с 15,6‰ до 17,4‰, СП – в пределах 11,6-13,6‰.

В Северо-Казахстанской области в 2000-2002 гг отмечается тенденция роста заболеваемости РШМ – с 12,8 до 15,4‰ со среднегодовым ИП 13,1‰. ИП по РТМ растет с 13,1 до 19,6‰, по СП – с 10,4 до 14,9‰. В динамике заболеваемость росла, затем был спад с 4,8 до 3,8‰ к 2003 году. В 2003-2005 гг отмечается снижение заболеваемости РШМ с 17,6 до 13,8‰ со средними показателями 15,6‰ и рост ИП по РТМ с 12,2 до 15,1‰, СП – в

пределах 8,9-11,5‰. Среднегодовой ИП по РШМ в третий период составил 14,4‰, динамика заболеваемости как по РШМ, так и по РТМ была не стабильной: 18,6 и 12,2‰ в 2006 году, соответственно, в следующем году – спад по РШМ до 11,7‰ и рост по РТМ до 14,1‰ и вновь спад интенсивных показателей РТМ до 10,9‰, при этом СП в среднем 8,6‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком шейки и тела матки по северному региону Республики показал при ранжировании большую распространенность РШМ в Костанайской, затем в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Заболеваемость по РТМ была первой по рангу в Костанайской, затем в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.